

Sygnały *wcześnie wykryte*

Indywidualne wskaźniki poprzedzające epizod lub pełny nawrót. Marlatt 1985: wczesne wykrycie = szybka interwencja = uniknięcie pełnego nawrotu. KAŻDY musi zidentyfikować SWOJE sygnały.

CZAS: 30 min · identyfikacja + lista Etap 4 CBT-E (sesje 16–20) · blueprint

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008); Marlatt & Gordon (1985)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **sześć kategorii sygnałów** wczesnego nawrotu (sekcja 1), zobacz **jak utworzyć osobistą listę** (sekcja 2). Sekcja 3 — Twoje sygnały. Sekcja 4 — plan działania per sygnał.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Wczesne sygnały nawrotu (*early warning signs*, EWS) — **indywidualne** wskaźniki poprzedzające epizod. Nie są *takie same* dla każdego klienta — **każdy musi zidentyfikować swoje**. Typowe kategorie: **jedzeniowe** (pomijanie posiłków, liczenie kalorii), **behawioralne** (izolacja, wielokrotne ważenie), **poznawcze** (myśli o wadze, zniekształcenia), **emocjonalne** (wzrost lęku, pustka), **cielesne** (zaburzenia snu, spadek energii), **społeczne** (unikanie spotkań). Marlatt & Gordon (1985) *Profilaktyka nawrotów*: rozpoznanie sygnałów jest **pierwszym krokiem** w zapobieganiu. Klient ma *spisaną* listę, regularnie ją przegląda. Gdy **2-3 sygnały** w tym samym tygodniu → *alarm* → intensyfikacja interwencji. Z listą można interweniować *wcześnie*, kiedy redukcja jest *łatwiejsza*. Lista EWS jest *obowiązkowym* elementem *blueprintu* końcowego.

01 ≡ Sześć kategorii sygnałów wczesnych

1 · JEDZENIOWE

Pomijanie posiłków, liczenie kalorii, wracanie do „zasad”, unikanie pokarmów, ważenie jedzenia.

2 · BEHAWIORALNE

Wielokrotne ważenie, body checking, więcej ruchu kompensacyjnego, sprawdzanie ubrań, izolacja.

3 · POZNAWCZE

Powrót myśli o wadze, porównywanie się, zniekształcenia („jestem gruba”), planowanie diety.

4 · EMOCJONALNE

Wzrost lęku, obniżenie nastroju, pustka, samotność, rozdrażnienie, poczucie braku kontroli.

5 · CIELESNE

Napięcie, zaburzenia snu, spadek energii, bóle głowy, problemy żołądkowe. Ciało reaguje wcześniej niż umysł.

6 · SPOŁECZNE

Izolacja, unikanie spotkań, mniej kontaktów, odsuwanie się od bliskich, mniej rozmów z terapeutą.

02 ● Jak utworzyć osobistą listę 10–15 sygnałów

Spójrz *wstecz* — na okresy, gdy bulimia się nasilała. Co poprzedzało? Często sygnały są *retrospektywnie* rozpoznawalne. Spróbuj zidentyfikować 10–15 *najsilniejszych* dla Ciebie sygnałów — po 1–3 z każdej kategorii.

Zasada alarmu: gdy **2-3 sygnały** pojawiają się w *tym samym tygodniu* → to *alarm*. Czas na **intensyfikację interwencji**: kontakt z terapeutą, powrót do dziennika, użycie planu awaryjnego.

03 \ Moje 10–15 sygnałów wczesnych

KATEGORIA	MÓJ KONKRETNY SYGNAŁ
Jedzeniowy	
Jedzeniowy	
Behawioralny	
Behawioralny	
Poznawczy	
Poznawczy	
Emocjonalny	
Emocjonalny	
Cielesny	
Społeczny	

04 Plan działania per sygnał

Dla każdego sygnału warto zaplanować **konkretną odpowiedź**. Co zrobię, gdy zauważę ten sygnał? Bez planu sygnał jest tylko *informacją* — z planem staje się *akcją*.

3 SYGNAŁY WCZESNE NAJBLIŻSZE MI

— z listy powyżej, te które rozpoznaję najczęściej

CO ZROBIĘ, GDY ZAUWAŻĘ 2–3 SYGNAŁY

— konkretne kroki: kontakt z terapeutą, powrót do dziennika, plan awaryjny

Klucz: personal warning signs są *jednym z najsilniejszych* narzędzi profilaktyki nawrotów. Marlatt & Gordon (1985) w *Relapse Prevention* uczynili EWS *standardem* w leczeniu uzależnień — mechanizm jest identyczny w bulimii. **Bez listy** nawrót przychodzi „*niespodziewanie*” — choć retrospektywnie sygnały były obecne tygodniami przedtem. **Z listą** nawrót staje się *widoczny* we wczesnej fazie, kiedy **interwencja jest łatwiejsza**. To różnica między *ślizgiem* (jeden epizod, łatwo wrócić) a *nawrotem* (pełny powrót objawów, trudniej). Fairburn (2008): w CBT-E lista EWS jest *obowiązkowym* elementem etapu 4 (sesje 16–20) i centralną częścią *blueprintu* (→ kolejny handout). Bez niej terapia jest *niezakończona*. **Aktualizacja:** lista *nie* jest statyczna. Co 3–6 miesięcy warto przeglądać i aktualizować — zmieniają się życiowe wyzwania, zmieniają się typowe wzorce. Sygnały z okresu studiów mogą być inne niż z okresu macierzyństwa. **Wskaźnik szczególnej uwagi:** kiedy klient mówi „*nic mi się ostatnio nie dzieje*” — często jest to *fałszywa cisza* przed nawrotem. Sygnały są obecne, ale klient ich *nie widzi* (lub nie chce widzieć). Regularny przegląd listy *na zimno*, co tydzień / dwa tygodnie, pomaga zachować świadomość.